



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : شيماء سيد حنفى محمود
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : مصر القديمة
العنوان : ..
رقم البطاقة : 28609120105566 رقم التليفون : 01128904889
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 12-09-1986 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....)
المقرر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: شيماء سيد حنفى محمود
National ID: 28609120105566



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Supportive and palliative Treatment

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

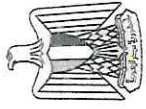


شيماء
سيد حنفى محمود
١٠ اش حسين مصطفى - الزهراء
مصر القديمه - القاهره



٢٨٦٠٩١٢٠١٠٥٥٦٦

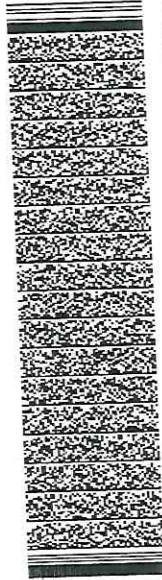
IS4893495



٢٠٢١/٠١ ٢٨٦٠٩١٢٠١٠٥٥٦٦
ربه منزل

أنقى
مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠١/١١



٢٨٦٠٩١٢٠١٠٥٥٦٦
٢٨٦٠٩١٢٠١٠٥٥٦٦

Patient's Name: Shaima Said Hanafi Mahmoud
Date: 2026-09-07
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: -40year-old female with right breast palpable lump from one year

Findings:

right breast.

- Fairly dense fibroglandular densities. (ACR b)
- UOQ, middle third irregular high density mass lesion with distortion seen in all area about 5x7cm ,no suspicious calcifications
- **Ultrasound** demonstrated shows irregular hypo echoic solid lesion seen between 11-12 o'clock at middle third, 7 cm from nipple ,reaching the skin causing thickening and dimpling with internal vascularity on color Doppler study measuring 35x26mm.
- Two level 1 enlarged pathological LNs nodes seen measuring 7x6mm and 12x10mm with focal cortical thickening 6 mm

left breast.

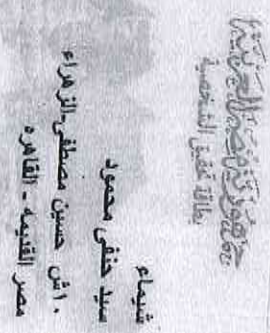
- Fairly dense fibroglandular densities. (ACR cb)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- **Retro areolar dilated ducts**
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

- right **breast (BIRADS 5): Malignant looking lesion for biopsy**
- left **breast (BIRADS 1): Normal study.**

Best Regards,

DR:Marwa M.Hassan



IS4893495

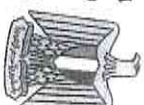
Y 87.912.1.0077



Y.Y.Y.Y.

PA7.917.1.0077

رَبِّهِ مُنْزِلٌ



Final

آتی

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠١/١١





Patient Name	شيماء سيد حنفى	Case No.	385562
Sex/Age	Female 40 Y	Patient No.	29049
Registered Date	19/9/2026 10:01:43 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	27/9/2026 02:33:16 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 08:45:52 AM	Pathology No.	2978/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 16/09/2026.

Gross Examination:

-Four grey, white tissue cores, ranging in size between 0.8 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1)
- DCIS: Absent
- Microcalcification: Present
- Angioinvasion: Absent
- Perineural invasion: Absent
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 20%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي القبرائيل - مصر - مختبر علم الأمراض



Patient Name	ثيحاء سيد حنفى	Case No.	385562
Sex/Age	Female 40 Y	Patient No.	29049
Registered Date	19/9/2026 10:01:43 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	27/9/2026 02:33:16 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 08:45:52 AM	Pathology No.	2978/26

- Her2: Negative Low (score 1+).

- Ki67%: 20%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

Patient's Name: Shaima Said Hanafi Mahmoud

Date: 2026-09-07

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: -40year-old female with right breast palpable lump from one year

Findings:

right breast.

- Fairly dense fibroglandular densities. (ACR b)
- UOQ, middle third irregular high density mass lesion with distortion seen in all area about 5x7cm ,no suspicious calcifications
- **Ultrasound** demonstrated shows irregular hypo echoic solid lesion seen between 11-12 o'clock at middle third, 7 cm from nipple ,reaching the skin causing thickening and dimpling with internal vascularity on color Doppler study measuring 35x26mm.
- Two level 1 enlarged pathological LNs nodes seen measuring 7x6mm and 12x10mm with focal cortical thickening 6 mm

left breast.

- Fairly dense fibroglandular densities. (ACR cb)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- **Retro areolar dilated ducts**
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

- right **breast (BIRADS 5): Malignant looking lesion for biopsy**
- left **breast (BIRADS 1): Normal study.**

Best Regards,

DR:Marwa M.Hassan